

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	善終照護作業標準 Operating Standards of Hospice Care				
編號	A31000-Q02-W-A24	制定者	HP 林佩瑜	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.7 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解病人臨終症狀及善終照護過程。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）臨終症狀

1. 臨終前之生理變化：

症狀	導因/出現的情況	建議之處理
疲倦 體力不支	瀕死前病人容易感到疲倦、體力不支，他們可能沒辦法走路，沒力氣翻身，沒辦法專心和別人講話，也沒力氣自己睜開眼睛，有時整天都在睡覺，常越睡越沈不容易叫醒，這是身體代謝改變的結果。	1. 持續執行病人日常舒適照護。 2. 指導家屬運用語言及非語言的方式陪伴病人。
意識混淆	病人對時間、地點、人物的混淆可能增加，辨別能力降低，少數的病人會出現躁動、坐立難安的情形，這可能與腦部缺氧或代謝改變有關。	1. 給予病人現實感的提醒。 2. 調整舒適安全的環境。 3. 躁動的護理及保護措施。 4. 討論鎮靜劑的使用時機。
看到其他人所看不見的人或事物	瀕死病人視力會漸漸模糊、目光無神，且可能看到其他人所看不見的人事物，例如已去世的親人或動物。有的病人會有臨死覺知，例如，預知自己將何時死亡或死後的歸處。	1. 用心傾聽，瞭解這些特別的訊息，以及對病人的意義。 2. 不需和病人辯論真假的問題，也不需為病人找理由解釋情境，或認為病人是幻覺，如此可能阻斷了病人表達內心感受的機會。
進食情形改變	臨終病人不想吃東西，不肯喝水，此為腸胃消化吸收功能退化，為自然過程，有時病人甚至會出現失去吞嚥和吸收的能力。	1. 通常病人不會有飢餓感，給予口腔護理，清潔病人的口腔內部並保持嘴唇滋潤即可。 2. 衛教家屬此時病人食慾變差及吞嚥困難，餵食、插鼻胃管反而可能會造成病人的負擔，如：嘔吐、腹脹、進食噎到的情形。

主題名稱	善終照護作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-A24	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/7

症狀	導因/出現的情況	建議之處理
解尿情形改變	1. 病人尿量會逐漸減少，顏色變深。 2. 病人若出現下腹痛、膀胱脹、想解尿卻無尿液排出，需評估可能有尿滯留情形。	1. 使用護墊或尿褲以維持病人的舒適及尊嚴。 2. 若病人有尿滯留情形時，可與醫師討論(單次)導尿的可行性。
便秘或失禁	此時因病人肛門括約肌張力消失，腸蠕動趨緩慢，故病人可能出現大便失禁或便秘的情形。	1. 檢查尿布頻率增加，維持病人皮膚的乾爽與舒適。 2. 若有持續便秘症狀，經評估可予腹部按摩等舒適護理。
血液循環變慢	病人手腳四肢出現冷冰冰，有時指甲和嘴唇會變藍或紫色，這些症狀是由於體內血液循環變慢變差的結果	1. 有些病人因知覺系統亦變差，故不會覺得冷或不舒服，此時可協助按摩及保暖。 2. 有時病人會不停冒汗，此時需為他擦澡，更換乾爽的衣服。
呼吸型態改變	病人臨終前呼吸型態會改變呈現陳式呼吸(俗稱喟嘆式呼吸)，有張口及呼吸變慢甚至是呼吸暫停的情形，這是臨終病人常會出現的症狀。	1. 觀察呼吸暫停的時間及次數。 2. 無需喚醒病人，可建議家屬增加陪伴時間。 3. 進行口腔護理，清潔病人的口腔內部並保持嘴唇濕潤。
瀕死咕嚕音或嘎嘎音	瀕死病人有時會在呼吸時發出很大的聲音，這是因為病人口腔的分泌物聚集在喉嚨的後部無力吞嚥，或氣管的黏液無力咳出滯留於咽喉內所造成的。	1. 抬高病人頭部 30~60 度或採側臥姿。 2. 適時用棉棒清除口腔黏液或痰液等異物。 3. 抽痰有時只能緩解幾分鐘或無改善，倘若反覆抽痰易徒增病人不適感，可使用藥物來抑制分泌物產生。
疼痛	當死亡臨近時，有些病人的疼痛和不舒服會減弱，有些病人則會加劇。	1. 視病人狀況調整止痛藥劑量，不可貿然停藥。 2. 生命最後 48 小時，13%病人可能可以減輕劑量，44%需要增加劑量，43%可維持原劑量。
聽覺	聽覺是最後消失的，死亡後八小時聽力仍然存在。	引導家屬與臨終病人道愛、道謝、道歉與道別。

2. 死亡徵象之確定：

- (1) 測脈搏或以聽診器聽是否有心跳音。
- (2) 觀測呼吸。
- (3) 瞳孔：以手電筒照瞳孔，呈現放大無反應。

(二) 遺體護理

1. 用物準備：臉盆、毛巾、溫水、紙膠(建議膚色)、紗布(視需要準備)、衣物、紙尿布，依病人家中習俗或宗教信仰備妥所需用物。
2. 謹慎移除身上的管路，如引流管、導管等，給予適當吸水敷料覆蓋。

主題名稱	善終照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A24	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/7

身體傷口的覆蓋，一般傷口可使用人工皮黏貼，腫瘤所造成的臉部缺陷需將缺口覆蓋，盡量維持遺體外觀的完整及美觀。遺體送殯葬前，應包紮完全、縫合傷口並移除醫療器具，以降低相關人員意外暴露往生者之血液或體液的機會。

3. 遺體護理流程：

- (1) 以溫水清潔全身，若肢體過於僵硬，可用熱毛巾熱敷關節處。
- (2) 協助穿好紙尿褲。
- (3) 協助將眼睛閉合，可請家屬協助輕輕將大體眼瞼合上，然後用熱毛巾熱敷 5 分鐘，或以膚色膠布剪成細長條，由上眼瞼貼至下眼瞼固定之。
- (4) 若口部張開無法閉合，可用小毛巾做成捲軸固定下顎並將頭部墊高。
- (5) 協助穿衣物、鞋、襪並做最後檢視。

4. 所有往生者遺體都可能帶有病原體，因此為保障護理及殯葬服務人員於照護未知是否有感染之遺體，相關人員應依標準防護措施盡量減少與屍體的血液、體液及組織接觸（包括執行手部衛生及依可能暴露情形穿戴手套、隔離衣、臉部防護具或口罩和護目鏡等），同時注意工作環境消毒，以降低傳染病的傳播機會。

（三）臨終前之準備

1. 照片：

- (1) 平時居家生活照，可收集整理成冊作為日後紀念。
- (2) 放大半身正面彩色照片，作為喪禮時使用。

2. 生平記事：

建議家屬事先可與病人一起整理照片、信件等具有紀念價值的文件，利用此過程進行生命回顧並交代遺囑。如：就學就業經過、個人之特殊經歷、貢獻等生平之記事。

3. 遺囑之內容：

遺物及遺產之處理分配、喪葬儀式處理、給親友的話、心願的表達與安排。

主題名稱	善終照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A24	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/7

4. 臨終時穿著之衣物：

- (1) 依照病人臨終前之安排。
- (2) 依照病人日常生活之習慣準備（個人喜歡的衣服、飾品、假髮等等）。
- (3) 請葬儀社協助處理。

5. 關於大體捐贈可聯絡社工師協助處理，而器官捐贈可連絡器官協調師。

（四）死亡後之相關行政手續

1. 死亡證明書之申請辦法：

- (1) 病人於住院期間，因疾病死亡由本院醫師開立死亡證明書，所需準備證件：
病人之身分證明文件（身分證或戶口名簿）。
- (2) 病人於住院期間，辦理病危、臨終出院或病人由本院返家途中於救護車上死亡，由家屬向本院申請「一般診斷證明書」，以利衛生所出具「死亡證明書」之參考。所需準備證件：病人之身分證明文件（身分證或戶口名簿）。
- (3) 居家病人或在機構往生者，請向當地衛生所申請遺體相驗手續並開立死亡證明書。所需準備證件：病人之身分證明文件（身分證或戶口名簿）及原就診醫院之病歷摘要或「一般診斷證明書」。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

主題名稱	善終照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A24	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/7

- (一) 王怡萍(2021)・2021 年安寧緩和護理專業進階課程講義(中區)・台北：台灣安寧緩和護理學會。
- (二) 台中市政府衛生局來函(2015, 6 月 5 日)・有關人類免疫缺乏病毒感染往生者遺體之殯葬處理事宜。

七、附件

(略)

主題名稱	善終照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A24	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
99.10.27	2.1	修改說明內容。	99 年 10 月 27 日護理部照護標準委員會通過
101.04.18	2.2	修改目的內容與說明內容修辭。 患者改病人。 修改六、參考資料：台灣安寧緩和醫學學會(2007)· 安寧緩和醫療-理論與實務 ·台北：新文京開發。	101 年 04 月 18 日護理部照護標準委員會通過
102.02.22	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.04.01	3.1	說明內容部份修辭。	103 年 04 月 01 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.04.07	3.2	1. 第三項第（四）目內容修辭：患者改為病人；診斷書改為一般診斷證明書。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 04 月 07 日護理部照護標準委員會通過
104.08.04	3.3	1. 第三項第（二）目之 2、3 內容增修有關人類免疫缺乏病毒感染往生者遺體之殯葬處理事宜。 2. 新增第六項參考資料。	104 年 08 月 04 日護理部照護標準委員會通過
105.02.02	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.02.06	3.4	第一項及第三項說明內容部份修辭。	106 年 02 月 06 日護理部照護標準委員會通過
107.02.12	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.02.14	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 5 修正器官捐贈協助單位。	108 年 02 月 14 日照護標準組會議

主題名稱	善終照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A24	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
		3. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	通過；108 年 03 月 13 日護理長會議通過；108 年 03 月 18 日督導會議通過公布
109.02.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.02.04	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.04.12	3.6	1. 第三項第二目之 2、3 內容增修說明內容部份修辭。 2. 增修第六項參考資料。	111 年 02 月 10 日照護標準組會議通過；111 年 03 月 09 日護理長會議通過；111 年 04 月 12 日督導會議通過公布
112.02.02	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.02.01	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.02.06	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.7	1. 第三項第一目第 1 點：建議之處理。 2. 第二目第 3 點之 5：內容增修說明內容部份修辭。	115 年 02 月 05 日照護標準組會議通過；115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。